

UIDC : Mme Kopf

Prof. Adrian Guggisberg
Service de Neuroréducation
adrian.guggisberg@hcuge.ch

Céphalées

Le cerveau en soi n'est pas sensible à la douleur. Les céphalées sont produites par une irritation des méninges, des vaisseaux, des sinus, des nerfs crâniens, ou de structures extracrâniennes.

Epidémiologie

- prévalence de tous les types de céphalées : ~70-90% de la population
- 6^{ème} motif de consultation médicale

Etiologies

Céphalées primaires

- Migraine
 - o avec Aura
 - o sans Aura
- Céphalées de tension
- Cluster Headache
- Névralgies (trijumeau, glossopharyngien, ...)
- Autres plus rares

Céphalées secondaires

- *maladies vasculaires*
 - o Hémorragie cérébrale
 - o Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)
 - o Hémorragie sous-durale (HSD)
 - o Accident vasculaire cérébral (AVC)
 - o Dissection carotidienne ou vertébrale
 - o Thrombose du sinus veineux
 - o Artérite de Horton
- *autres hypertensions intracrâniennes*
 - o Tumeur cérébrale
 - o Abscès cérébral
- troubles de circulation du LCR
 - o Hydrocéphalie
 - o Hypotension LCR
- maladies ophtalmologies
 - o Glaucome
 - o Myopie, Hypermétropie
- maladies ORL
 - o Sinusite
- maladies dentaires
- autres maladies
 - o Hypertension artérielle
 - o Méningite
 - o toxique-métabolique, médicaments !
- Céphalées après traumatismes crâniens
- Céphalées spondylogènes
 - o Spondylose cervicale
 - o « coup du lapin »

Anamnèse

Temps : quand, depuis quand, durée ?

- « coup de tonnerre », « thunderclap headache » → HSA !
- péjoration rapide → migraine
- péjoration lente → céphalées de tension
- apparition au matin, au réveil → masse intracrânienne ?
- récidivant → migraine, cluster headache, céphalées de tension épisodiques, névralgie, ...
- tout le temps → céphalées induites par médicaments, tension, migraine
- durée qq secondes → névralgie
- durée 15 – 180 minutes → cluster headache
- durée 4 – 72 heures → migraine

Localisation

- focal, tj au même endroit → tumeur ? masse ?



Intensité

- très haute, ne peut plus continuer une activité → névralgie, cluster headache, migraine

Caractère de la douleur

- resserrement, pesante, constrictive → céphalées de tension
- pulsatile, lancinant → migraine
- décharge électrique → névralgie

Modulation de la douleur

- mieux au réveil → céphalées de tension, migraine
- pire au réveil → masse intracrânienne

- phonophobie, photophobie → migraine
- péjorée par activité physique → migraine
- péjorée en position couchée → masse intracrânienne
- péjorée en position debout → hypotension LCR

Symptômes concomitants

- Nausées, vomissements → migraine, masse intracrânienne, hémorragie
- Aura : phénomène visuelle, troubles de sensibilité, parésie, diplopie, troubles de conscience → migraine
- Claudication masticatoire (doit faire des pauses en mangeant) → artérite de Horton
- Larmes, injection conjonctivale → cluster headache, glaucome
- Ne peut pas rester calme → cluster headache
- Syndrome de Horner → Dissection carotidienne, cluster headache
- Amaurose fugace → dissection carotidienne

Anamnèse familiale

- Migraine
- Hémorragies cérébrales (HSA, risque 4x plus haut en cas d'AF positive).
- Thromboses

Anamnèse systémique

- Tabac → Thrombose du sinus, AVC
- OH → hémorragie
- HTA → hémorragie, AVC
- Médicaments : contraceptives orales (thrombose du sinus), analgésiques (céphalées induites par les médicaments)

Examen

Général

TA, Pouls, T

Points douloureux au niveau des sinus nasals

Etat dentaire

Morsure de langue → crise épileptique

Status neurologique

FS :

- Vigilance, orientation

NC :

- Injection conjonctivale → cluster headache, glaucome aiguë à angle fermé
- Pression des yeux → glaucome aiguë à angle fermé
- Fond d'œil : œdème papillaire → hypertension intracrânienne
- Atteinte de nerfs crâniens → pathologie intracrânienne

Nuque :

- Méningisme

VL :

- signes focaux

Signes d'alarme

- Céphalées d'apparition brutale
- Haute intensité
- Céphalées différents que d'habitude
- Histoire de traumatisme
- Première manifestation après 40 ans
- Fièvre, Méningisme
- Signes neurologiques focaux, crises épileptiques
- Troubles de vigilance

Céphalées primaires

Migraine

Epidémiologie

- Prévalence 10-30%
- femmes : hommes = 3-4 : 1 chez l'adulte, chez l'enfant 1 : 1
- Manifestation typiquement entre 15 et 25 ans

Pathophysiologie

- Facteurs génétiques : gènes codant pour des canaux ioniques induisent une prédisposition de réaction migraineuse du cerveau
- Déclencheurs : souvent changements de temps, stress ou détente après stress, rythme sommeil irrégulier, faim, qq aliments ...
- Aura : 2 hypothèses
 - o Hypothèse vasculaire : hypoperfusion corticale
 - o Hypothèse neurogène : « spreading depression » = inhibition de activité neuronale qui s'étend sur le cortex avec une vitesse de 2-3 mm par min.
 - Déficits neurologiques lors de l'aura
- Céphalées : activation du système trigéminovasculaire, du locus coeruleus, et du noyau Raphé au niveau du tronc cérébral → sécrétion de substances vasoactives → vasodilatation, réaction inflammatoire aseptique des artères dures → douleurs

Clinique (voir critères de l'IHS)

- Migraine sans aura
 - o Céphalées typiquement unilatérales, pulsatiles, forts
 - o Péjoration par activité physique
 - o Phonophobie, photophobie
- Migraine avec aura

L'aura survient typiquement AVANT les céphalées. Elle dure <1h et est complètement réversible.

 - o aura ophtalmique : scintillement dans les 2 champs visuels (scotomes) qui s'étend du centre vers la périphérie
 - o paresthésie, hypoesthésie unilatérale
 - o parésie unilatérale
 - o aphasie
 - o migraine basilaire : dysfonctionnement du tronc cérébral pdt l'aura → troubles de conscience, dysarthrie, diplopie, ataxie, parésies bilatérales
 - o migraine rétinienne : scotome ou cécité unilatérale pdt <1h

Complications

- Migraine chronique : >15 attaque / mois pdt au moins 3 mois
- Status migraineux : >72h ou intervalle <4h.
- Les femmes avec migraine et aura ont un risque d'AVC plus élevé

Diagnostic

- Anamnèse et examen !
- Imagerie uniquement si « signes d'alarme » (voir ci-dessus)

Thérapie

- de l'attaque : traiter le plus vite possible !
 - o Environnement calme et sombre, glaçons sur la tête
 - o Antiémétiques : Primperan®, Motilium®
 - o Analgésiques : Aspirine®, Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenac, Indométacine, ev. avec caféine. Eviter les opioïdes.
 - o Triptanes (agonistes du récepteur de sérotonine): Imigran®, Zomig®, Naramig®, ... Effet vasoconstrictif. Eviter pdt l'aura ! Contre-indiqué chez les patients avec coronaropathie.
 - o Problème : céphalées induits par analgésiques et triptanes en cas de consommation chronique.

- de base (prophylactique) : indiqué si au moins 3 attaques / mois ou si attaques sévères ou si attaque ne peuvent pas être traités.
 - o 1^{er} choix
 - Béta-bloquants : Propranolol (Inderal®), Metoprolol (Beloc®)
 - Anticalcique : Flunarizine (Sibelium®)
 - Antiépileptiques : Valproate (Depakine®), Topiramate (Topamax®)
 - o 2^{ème} choix
 - Antidépresseurs : Amitriptyline (Saroten®, Tryptizol®), SSRI
 - o Anticorps contre calcitonin gene related peptide (CGRP) : fremanezumab (Ajovy®), galcanezumab (Emgality®) ou son récepteur : erenumab (Aimovig®) injection sous-cutané par pen.
Nouvelle alternative efficace, si échec du traitement de première ligne
 - o Autres :
 - Toxine botulinum
 - Transcranial magnetic stimulation (TMS)

Céphalées de tension

Epidémiologie

- prévalence : 60-80%
- femmes : hommes = 1.5 : 1

Pathophysiologie

- peu comprise
- Contribution des muscles péricrâniens ?
- Activation du noyau Raphé qui inhibe un système anti-nociceptif endogène → sensibilité à la douleur ↑
- Continue entre migraine et céphalées de tension ?

Clinique

- Céphalées de tension épisodiques
 - o Douleurs bilatérales, d'intensité légère à modérée, constrictives, pesantes, non-pulsatiles
 - o Durée 30 min – 7j.
 - o Pas de péjoration par activité physique
 - o Aucun ou maximum 1 des phénomènes suivants : photophobie, phonophobie, nausée
 - o Pas de vomissement
 - o Pas d'indices pour des céphalées secondaires
- Céphalées de tension chroniques
 - o critères ci-dessus et
 - o au moins 15j avec céphalées / mois depuis au moins 6 mois

Thérapie

- Journal des céphalées pour découvrir des déclencheurs et des facteurs soulageants.
Réduction des facteurs de stress.
- ttt de l'attaque :
 - o Aspirine®, Paracétamol, Ibuprofène, Naproxène, huile de menthe topique sur les tempes
 - o les Triptans sont sans effet !
- ttt prophylactique
 - o indication : céphalée >12h/j, >10j /mois sur >3 mois
 - o Antidépresseurs tricycliques : Amitriptyline (Saroten®, Tryptizol®)

Cluster headache

Epidémiologie

- Prévalence : ~0.3%
- femmes : hommes = 1 : 4-8 !
- début typiquement entre 30 et 40 ans

Pathophysiologie

- inconnue
- inflammation aseptique du sinus caverneux pdt les épisodes ?

Clinique

- Douleurs très intenses, unilatérales orbitaires, supraorbitaires ou temporales, d'apparition rapide sans précurseurs
- Durée 15 – 180 min
- Au moins 1 des symptômes suivants ipsilatéral aux douleurs:
 - o syndrome de Horner avec miosis et ptose
 - o injection conjonctivale
 - o larmes
 - o rhinorrhée et congestion nasale
 - o œdème périorbital
 - o sudation au visage et au front
- accumulation des attaques en « cluster » : 1 attaque tous les 2 jours jusqu'à 8 / jour.
- forme épisodique : intervalle au moins 14j
- forme chronique : intervalle <14j depuis >1 année

Thérapie

- de l'attaque
 - o O2 avec masque
 - o Triptans
- prophylaxie
 - o indication : pdt un épisode de « cluster », jusqu'à 14j après la dernière attaque
 - o 1^{er} choix
 - Verapamil (Isoptin®)
 - o 2^{ème} choix
 - Prednisone
 - Valproat
 - Lithium

Névralgie du trijumeau

Epidémiologie

- Prévalence : ~40 / 100'000
- femmes : hommes = 3 : 2
- début typiquement entre 40 et 60 ans

Etiologies

- formes secondaires : Tumeurs, SEP, Anévrismes, Malformation artério-veineux, compression vasculaire
- idiopathique : hypothèses : compression microvasculaire, dysfonction du système trijumo-vasculaire, dysfonction centrale

Clinique

- Douleurs unilatérales paroxystiques du visage (rarement bilatérales)
- Durée secondes à max 2 minutes
- Au moins 4 des caractéristiques suivantes :
 - o localisation correspond au territoire sensible d'un ou plusieurs branches du trijumeau

- douleur soudaine, superficielle, lancinante ou brûlante
- très haute intensité
- déclenchement par activités comme : manger, parler, laver le visage, se peigner, brosser les dents
- absence de douleurs entre les attaques
- Pas de déficit neurologique
- Apparition stéréotypée des attaques

Diagnostic

- IRM cérébrale à la recherche d'une forme secondaire

Thérapie

- médicamenteuse
 - 1^{er} choix : Carbamazépine (Tegretol®)
 - Phénytoïne
 - Baclofène (Lioresal®)
- invasive
 - décompression microvasculaire d'après Janetta
 - Thermo-coagulation sélective percutanée du Ganglion de Gasser
 - Injection de glycérol dans le Ganglion de Gasser

Céphalées induites par les médicaments

Epidémiologie

- 5-8% des patients avec céphalées
- femmes : hommes = 5 : 1

Pathophysiologie

- peu clair

Clinique

- Consommation élevée d'analgésiques ou de triptans
- Douleurs constrictives, qq fois pulsatiles, uni- ou bilatérales, de localisation variée, présentes déjà au réveil

Thérapie

- Bonne information et motivation du patient
- Sevrage ambulatoire ou stationnaire